

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	骨盆腔炎症 Pelvic Inflammatory Disease				
	編號	制定者	核准者	公布日期	檢閱日期
制定單位	A31000-Q03-W-M06	護理部	R9 黃麗華	吳姿蓉	98 年 05 月 31 日
版本/總頁數	第 3.8 版/8 頁	審查者	劉俞均	修正日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解骨盆腔炎症的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

骨盆腔炎症(pelvic inflammatory disease, PID)是指上行性骨盆感染，亦即上生殖道（子宮頸以上）及骨盆腔血管系統之各種感染。骨盆腔炎症包括急性子宮內膜炎、急性或慢性輸卵管卵巢炎、急性腹膜炎、突發性或慢性輸卵管卵巢膿腫。85%是經由性病感染。

（二）症狀

- 1.急性骨盆腔炎症：下腹部兩側痙攣性、持續性疼痛，移動或下床活動時更增加疼痛感，常伴隨不正常陰道出血及濃稠而臭的膿性分泌物，甚至出現倦怠感、腹脹、陰道分泌物增加、噁心、嘔吐、寒顫、發燒、小便困難、性交疼痛。
- 2.慢性骨盆腔炎症：骨盆持續有鈍痛感、繼發性痛經、功能失常性子宮出血和急性症狀周期性發作。骨盆檢查時，骨盆腔有壓痛，子宮體旁結締組織(parametrium)變厚，卵巢和輸卵管固定不易移動。
- 3.合併症：不孕、腹膜炎、敗血性休克。

主題名稱	骨盆腔炎症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M06	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/8

(三) 常見檢查

- 1.實驗室檢查：白血球上升、紅血球沉降速率上升。
- 2.抹片檢查(smears)：抹片採檢過程相當簡單且快速、無痛，完成採檢，之後再經過染色後，於顯微鏡底下觀察是否有不正常細胞存在。
- 3.陰道細菌培養(culture)：通常約 3-7 天報告會出來。
- 4.格蘭氏染色試驗：需於 24 小時內發報告。
- 5.超音波檢查：為第一線的診斷工具，可偵測出體內發炎的位置及範圍，腹部超音波檢查需於檢查前先漲尿有助顯像；陰道超音波檢查則於檢查前排空膀胱。

(四) 常見治療

處理骨盆腔炎，必需根據下列三個基本因素：

- 1.有正確的診斷，能明確的區分淋病和非淋病感染。
- 2.選擇有效的抗生素。
- 3.根據檢查和病史，決定病人住院治療或門診治療。
- 4.一般急性骨盆腔炎症經過正確的診斷和給藥，約 24-48 小時後，症狀便會有所改善，70%的病人在門診接受治療即可。如有下列情況，便需考慮住院治療：
 - (1) 體溫超過 38°C。
 - (2) 懷疑有子宮附屬器腫塊，或是骨盆腔膿瘍。
 - (3) 上腹膜炎徵候(upper peritonitis sign)。
 - (4) 懷孕。
 - (5) 在門診治療失敗或不能吞食藥丸。
 - (6) 診斷有疑問時。

A. 急性骨盆腔炎症：

一般病人患有急性炎症時，多半有發燒，尤其合併有腹膜炎徵候時，應由靜脈注射提供水份，直到症狀消失或穩定。Minocycline和Doxycycline是四環素的新產品，第一次先以200mg靜脈注射，以後每隔12小時以100mg靜脈注射，一直到燒退24小時後才改用口服，每隔12小時給100mg，共10天。

主題名稱	骨盆腔炎症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M06	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/8

此外，Ampicillin、Tetracyclin亦是常使用的藥物。

B. 慢性骨盆腔炎症：

慢性骨盆腔炎症病人，除了要找出可能的誘發因素之外，需接受徹底的抗生素來治療，約1~2週，讓炎症慢慢減輕及減少發生頻率，最後能消失。

其如果沒有其它的合併症，其治療原則為多休息和熱敷骨盆腔。

(五) 護理問題

1. 焦慮感受／與對疾病不了解有關。
2. 易感染／與缺乏安全性行為及個人衛生習慣知識有關。
3. 疼痛不適／與骨盆腔炎症引起有關。

(六) 護理措施

1. 焦慮感受／與對疾病治療不了解有關
 - (1) 評估病人焦慮程度及主要原因。
 - (2) 鼓勵及引導病人說出心中的感受和想法，以及目前不適的症狀，並給予適當的醫療處置及護理。
 - (3) 運用同理心，耐心地傾聽病人心中的感受和想法，尋找引起焦慮的原因。
 - (4) 主動提供正確的疾病及治療的相關資訊給病人，適時地澄清及修正其錯誤的觀念，以減輕病人的焦慮感。
 - (5) 執行醫療處置或護理照護前，應給予詳細解釋其準備工作及注意事項，並提供衛教單張閱讀，以減輕病人的不安感。
 - (6) 執行醫療處置或護理照護時，應注重病人之隱私，勿過度裸露病人身體隱私部位，必要時用屏風遮擋，請異性迴避。男性醫師幫女性病人做婦科檢查時，女性護理人員應要陪同在旁。
 - (7) 利用行為或認知策略，教導病人規律的呼吸、放鬆的技巧（如按摩）、冥想等，以減輕焦慮。
 - (8) 轉移病人注意力，如聽音樂、聊天。
 - (9) 介紹相同的病人，彼此經驗分享。

主題名稱	骨盆腔炎症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M06	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/8

(10)探視、陪伴及心理支持，增加安全感，以減少焦慮。

(11)隨時評估病人焦慮改善狀態。

(12)若病人焦慮感持續無法改善，必要時依醫囑給予藥物治療，如：鎮靜、精神神經安定劑。

2.易感染／與缺乏安全性行為及個人衛生習慣知識有關

(1) 每班監測陰道分泌物之顏色、氣味、濃稠度情況及周圍皮膚之完整性。

(2) 監測可顯示感染的實驗室檢查，並報告異常現象。

(3) 教導病人或主要照顧者炎症症狀，如紅、腫、熱、痛及徵象，如發燒、流膿，若有以上之情形應通知醫護人員。

(4) 每日沐浴和大小便後應適當的清潔，勿陰道灌洗，因為反而會破壞陰道正常菌叢而增加感染的機會。

(5) 應保持會陰部乾燥，勿穿過緊、不透風且不吸汗的衣物。

(6) 感染期間儘可能避免有性行為的發生，如果需要最好使用保險套，避免交互感染或是感染更嚴重。

(7) 對於停經後的女性，由於雌性素分泌減少，陰道黏膜細胞和皮膚失去肝醣，陰道呈鹼性，組織萎縮，因此易造成感染現象，護理人員應教導病人如何使用含荷爾蒙的陰道栓劑，或是陰道專用的荷爾蒙藥膏，並教導在使用每種藥物前應先洗手的重要性，可以避免二度感染。

3.疼痛不適／與骨盆腔炎症引起有關

(1) 評估病人的疼痛部位、程度（0 不痛～10 最痛）、頻率（間歇、持續）、發作時間、持續時間及特徵（刺痛或拍動痛、深沉或表淺），並記錄疼痛的變化。

(2) 監測生命徵象的變化，如：疼痛時，血壓上升，心跳、呼吸次數增加。

(3) 與病人或家屬共同討論減少或排除疼痛的方法。

(4) 評估病人使用疼痛控制方法的意願，在病人選擇疼痛控制方法時，如止痛劑、止痛藥、自控式止痛等，應給予教導與支持。

(5) 感染期間儘可能避免有性行為的發生，避免疼痛更嚴重。

主題名稱	骨盆腔炎症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M06	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/8

(6) 教導病人疼痛時採取舒適的臥位，如側臥、半坐臥、軀體彎曲位或端坐臥勢。

(7) 鼓勵病人運用熱敷、按摩背部及休息來緩解疼痛的不適感。

(8) 教導病人放鬆技巧或轉移注意力，如漸進式肌肉放鬆法、按摩、聽音樂、看電視、散步、閱書、聊天，以減緩疼痛。

(9) 多探視、陪伴及心理支持，增加安全感，以減緩疼痛。

(七) 衛教指導

1. 飲食方面：無特殊限制，採均衡飲食即可，若有噁心嘔吐現象可以採少量多餐或是較清淡飲食。

2. 疼痛方面

(1) 教導活動時採漸進式，減少腹部牽扯，減輕腹部疼痛。

(2) 依醫囑止痛藥服用。

3. 活動方面：無限制，急性期疼痛時可以採漸進式活動，減少腹部牽扯，減輕腹部疼痛。

4. 衛生方面

(1) 陰道有分泌物，應勤換產墊或棉墊，以保持乾淨乾燥，避免感染。

(2) 如廁後衛生紙應由前往後擦拭，勤換棉墊，避免感染。

(3) 每日身體清潔，建議宜採淋浴方式，勿盆浴及陰道灌洗，避免感染。

5. 性方面：需在醫師診察治癒後，視情況恢復性生活。

6. 其他方面：出院後若有以下情形應立即回診：體溫 $>38^{\circ}\text{C}$ 以上、腹部疼痛、陰道分泌物呈膿性狀且量多惡臭。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	骨盆腔炎症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M06	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/8

五、 流程圖

(略)

六、 參考資料

- (一) 余玉眉、周雨樺、蕭仔伶、何美華、孫瑞瓊、林淑玲、黃樹欽、陳怡靜、徐莞雲
(2020)．*產科護理學*（十版），新文京。
- (二) 蔡宏志、蘇棋楓(2024)．婦女慢性骨盆疼痛．*臺灣醫界*，67(3)，23-26。
- (三) Darville, T. (2021). Pelvic inflammatory disease due to neisseria gonorrhoeae and chlamydia trachomatis: immune evasion mechanisms and pathogenic disease Pathways. *The Journal of Infectious Diseases*, 224, 39-46.

七、 附件

(略)

主題名稱	骨盆腔炎症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M06	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	增加及修改定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題及衛教指導之內容。	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	醫護部改護理部。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	修正錯別字及說明(七)6.其他方面:刪除大約住院 5-7 天。	102 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.2	1.第三項第(一)目部份內容刪修。 2.更新第六項文獻參考資料。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.3	1.第三項說明內容將參考文獻出處呈現於內文中。 2.第六項文獻參考資料更新。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日 護理長會議通過;108 年 09 月 23 日 督導會議通過公布。
109.08.18	3.5	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日 照護標準組會議通過; 109 年 08 月 12 日 護理部會議通過。

主題名稱	骨盆腔炎症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M06	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
			理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.10.19	3.6	第三項第四日常見治療的英文。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過;110 年 10 月 13 日護理長會議通過;110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	3.7	1. 第三項第一、三目說明內容修訂。 2. 第三項第五、六目之護理問題名稱修訂。 3. 第六項參考資料修訂。 4. 刪除內文參考文獻。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過;111 年 10 月 12 日護理長會議通過;111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.10.15	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.01.06	3.8	1.第三項第一、二、三目英文修訂。 2.第三項第四目第 4 點之(1)字詞修訂。 3.第六項參考資料修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過;114 年 12 月 10 日護理長會議通過;115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。